

# Postmenopozda Dişeti Çekilmesi — Östrojen Kaybı ve Bakım

Yazan: *duygu-karaosmanoglu* · Yayın: 3 Mayıs 2026

## Postmenopozda Dişeti Çekilmesi — Östrojen Kaybı ve Bakım

01 |

### Kısa Özet

Düzgün, pembe ve sağlıklı dişetleri güzel bir gülüş için çok önemlidir. Postmenopozda ise dişeti çekilmeleri, çoğu kadının düşünmediği ama hormonal geçişle doğrudan bağlı olan bir alanda biraz daha sık karşımıza çıkmaya başlar. Genel olarak iki tip çekilmeden bahsedebiliriz: **hassas ve ince dişeti yapısına bağlı** olanlar ve **bakteriyel kaynaklı** olanlar. Bu yazı belirti, neden, önlem, tedavi çatısında postmenopozal değişimi, östrojen kaybının doku üzerindeki etkisini, pratik bakım direktiflerini ve ne zaman diş hekimine gitmek gerektiğini sade bir biçimde topluyor.

02 |

### Dişeti Çekilmesi Nedir, Postmenopozda Neden Sıklaşır?

Dişeti çekilmesi, dişetin diş yüzeyinden kademeli olarak geri çekilmesi ve diş kökünün açıkta kalmaya başlamasıdır. Toplumda en sık karşılaşılan şikâyetlerden biridir; ancak postmenopoz dönemine geçişle birlikte hem sıklığı hem de ilerleme hızı bir miktar artar.

Bunun arkasında üç birleşik etken vardır: **azalan östrojen**, **tükürük üretiminde değişim** ve **alveolar kemik metabolizmasındaki dönüşüm**. Postmenopozda kadınların önemli bir kısmı periodontal sorunlarda artış bildirmiştir (iyi kanıt) . Bu artış dramatik bir tablo değil; ama önleyici bakım yaklaşımının

bu dönemde özellikle kıymetli olduğunu gösteriyor.

03 |

## İki Tip Çekilme — Hassas Yapı ve Bakteriyel Köken

*Genel olarak 2 tip çekilmekten bahsedebiliriz; her ikisi de postmenopoz döneminde farklı şekilde belirginleşebilir.*

**1 — Hassas ve ince dişeti yapısına bağlı çekilme:** Doğuştan veya sonradan ince dişeti yapısı olan kadınlarda bazı alışkanlıklar çekilmeyi tetikler. Postmenopozda bağ doku yapısının değişmesi bu hassasiyeti biraz daha öne çıkarır.

**Diş gıcırdatma (bruksizm):** Dişlerinde yaygın ya da bölgesel üçgen çekilmeler oluşturur. Bite guard kullanımı önerilir. Postmenopoz stres dönemiyle birleştiğinde gıcırdatma sıklığı artabilir.

**Yanlış diş fırçalama:** Sert fırça ve yanlış teknik — özellikle köşe dişlerde — ciddi çekilmeler yaratabilir. Uygun fırça (yumuşak/orta) ve fırçalama tekniği öğrenilmelidir.

**Hatalı yapılmış dolgu ve kaplamalar:** Dişetine ve kapanışa gereken özenin gösterilmediği durumlarda dişeti çekilmesine sebep olur; fark edilince en kısa sürede yenilenmeleri gerekir.

**2 — Bakteriyel kaynaklı dişeti çekilmeleri:** Bölgesel bakteri birikimleri — özellikle alt çene ön bölgede — çekilmeye sebep olur. Çoğu zaman basit bir diştaşı temizliği ve sonrasında iyi bakım problemi halleder. Postmenopozda tükürük üretiminin azalmasıyla bakteri birikimi kolaylaşabildiği için bu tip çekilmeler bu yaş bandında bir miktar daha hızlı ilerleyebilir.

04 |

## Östrojen Kaybı Dişeti Dokusunu Nasıl Etkiler? — Kısa Mekanizma

*Östrojen reseptörleri yalnızca üreme dokularında değil, dişeti dokusunda da yer alır. Postmenopozda östrojen düşüşü üç ana noktada görünür hale gelir.*

**Bağ doku ve kollajen değişimi:** Dişetinin esnek ve dolgun yapısını sağlayan kollajen lifleri, sistemik östrojen düşüşüyle birlikte daha ince bir tablo gösterir (orta-iyi kanıt) . Bu, mekanik travmaya (sert fırça, gıcırdatma) karşı doğal toleransı düşürür.

**Tükürük üretiminde azalma:** Postmenopozda kadınların önemli bir kısmı ağız kuruluğu (xerostomia) belirtileri yaşar; tükürük azaldığında bakterilerin tabii temizlenmesi de azalır. Bu da plak birikimini ve dişeti enflamasyonunu kolaylaştırır.

**Alveolar kemik metabolizması:** Dişleri tutan kemik (alveolar kemik) sistemik kemik metabolizmasının bir parçasıdır; postmenopozal kemik kaybı (osteoporoz) ile alveolar kemik kaybı arasında ölçülebilir bir

bağ vardır (iyi kanıt) . Diş desteği zayıfladıkça çekilme ve diş hareketi belirginleşebilir.

Bu üç değişim eşzamanlı olduğunda, postmenopoz hassasiyeti ortaya çıkar. Önemli olan, bu hassasiyeti panik konusu değil; *özen gösterilmesi gereken bir alan* olarak okumak.

05 |

## Postmenopozal Risk Faktörleri ve Bakım — Pratik Liste

*Aşağıdaki risk faktörleri postmenopoz döneminde dişeti çekilmesini hızlandırabilir:*

- **Sigara kullanımı** — periodontal hastalık riskini en güçlü artıran faktör
- **Bruksizm (gece diş gıcırdatma)** — postmenopoz stres döneminde sıklaşır
- **Yanlış fırçalama tekniği** — sert fırça + yatay hareket
- **Ağız kuruluğu** — postmenopozda yaygın; bakteri birikimini kolaylaştırır
- **Düzensiz diş hekimi ziyareti** — diştaşı birikimi sessizce ilerler
- **Diabet, Sjögren sendromu, otoimmün durumlar** — dokuyu daha kırılgan kılar
- **Bazı ilaçlar** (antidepresan, tansiyon ilacı) — ağız kuruluğunu artırabilir

Pratik bakımda dikkat edilecek temel adımlar — sayısal pratik direktiflerle:

**Diş fırçalama:** Sabah ve akşam, günde iki defa, ikişer dakika. Yumuşak veya orta sertlikte fırça; yatay sürtme yerine 45 derece açıyla dişeti hattından dişe doğru hafif hareket. Elektrikli fırça özellikle yanlış teknik alışkanlığı olan kişilerde yardımcı olabilir.

**Diş ipi:** Günde en az bir defa. Diş fırçası iki dişin arasını tam anlamıyla temizleyemez; ara yüzeylerdeki plak diş ipi ile ortadan kalkar. Diş ipini kullanmamak postmenopozda ara yüz çürüklerinin sık nedenidir.

**Diştaşı temizliği:** 6 ayda bir profesyonel kontrol ve gerekirse temizlik. Postmenopozda bu süre kişisel risk profiline göre biraz daha sıklaştırılabilir (3-4 ayda bir).

**Asitli gıdalar:** Diş fırçaladıktan yarım saat öncesinde ve sonrasında portakal suyu, gazlı içecek, asitli meyve gibi asitli gıdalardan kaçınmak — minenin aşınmasını azaltır.

**Su tüketimi:** Tükürük üretimini destekleyen en doğal adım. Şekersiz sakız da tükürük akışını uyarır.

**Bruksizm için gece koruyucu:** Gıcırdatma şüphesi varsa (sabah çene ağrısı, baş ağrısı, dişlerde aşınma) diş hekiminin önereceği özel hazırlanmış bite guard etkilidir.

Dikkat çekmek istediğimiz ### Hekiminize danışmanın anlamlı olduğu durumlar Aşağıdaki belirtiler tek başına bir tanı anlamına gelmez; ama hekim değerlendirmesinde fayda görebileceğin durumlardır. - Diş eti kanaması düzenli ve kontrolsüz devam ediyorsa — periodontoloji değerlendirmesi şart - Diş gevşekliği veya ısırırken hareketi — alveolar kemik kaybı sinyali - Şişlik, abse, yüzeysel ağrı + ateş — akut enfeksiyon, vakit kaybetmeden diş hekimine - Sigara + postmenopoz — periodontal hastalık riski iki kat artar; bırakma planı kıymetli - Yoğun bruksizm + dişeti çekilmesi — gece koruyucu olmadan beklemek

riski büyütür - Diabet veya Sjögren tanısı — ağız hijyeni planı bireyselleştirilmelidir - Antidepresan, tansiyon ilacı kullanan kadınlarda kuru ağız + dişeti çekilmesi birleşimi - Diş ipi kullandığınızda iki haftadan fazla süren kanama — gizli enflamasyon işareti Bu liste teşhis amaçlı değildir; ağız sağlığında bir hekimle konuşmaya değer kabul edilen durumların hatırlatıcısıdır. ## Tedavi Adımları — Hangi Durumda Ne Yapılır? Tedavi planı kademelidir; \*her durumda öncelikle\* çekilmenin sebebini bulmak ve onu ortadan kaldırmaktır. \*\*Erken çekilme (yüzeysel) + iyi bakım:\*\* Çoğu zaman uygun fırça-fırçalama tekniği eğitimi, diştaşı temizliği ve düzenli takip yeterlidir. Tablo ilerlemiyorsa ek müdahale gerekmez. \*\*Bakteri birikmesinden kaynaklanan çekilme:\*\* Mutlaka profesyonel bir diştaşı temizliği uygulanır; bakteri artıkları uzaklaştırılır. Sonraki dönemde günlük bakım disiplini sürdürülür. \*\*Dişeti hastalığı (periodontitis) eşlik ediyorsa:\*\* Daha derin bir periodontal tedavi gerekir; bakteri kontrol altına alınır, gerekirse periodontoloji uzmanı yönlendirmesi yapılır. Erken yaşlarda karşılaşılan dişeti problemleri agresif tipte olabilir; genetik geçiş söz konusudur. Postmenopozda yıllar içinde sessizce ilerlemiş bir tablo olabilir. \*\*İlerlemiş çekilme (estetik veya sağlık açısından gereklilik):\*\* Ağız başka bir bölgesinden alınan dişeti dokusu, çekilme olan bölgeye yamanarak tedavi yapılır (greft operasyonu). Postmenopozda bu seçenek için karar — kemik desteği, sigara durumu, sistemik sağlık gibi faktörlerle birlikte bireysel olarak değerlendirilir. Tüm bu adımlar boyunca \*"yüze yakışanı arayan"\* yaklaşım önemini korur — agresif estetik müdahale yerine, doğal görünümü ve sürdürülebilir bakımı önceliklendiren karar zinciri uzun vadede daha değerlidir. ## Sıkça Sorulanlar ### Hormon replasman tedavisi (HRT) dişeti çekilmesini düzeltir mi? Doğrudan "düzeltir" demek mümkün değil; ama bazı çalışmalar sistemik östrojen tedavisinin postmenopozal dişeti hassasiyetini ve alveolar kemik kaybı hızını \*azaltabildiğini\* bildirmiştir (sınırlı—orta kanıt) . Etki büyüklüğü orta düzeyde ve bireysel değişkenlik gösterir; HRT kararı dişeti sağlığı tek başına bir gerekçe değildir, ancak HRT alan kadınlarda periodontal sağlık parametrelerinde küçük bir avantaj gözlenebilir. Bu konuda hem diş hekiminizle hem jinekoloğunuzla birlikte değerlendirme yapmak en mantıklı yoldur. ### Hangi diş macunu uygundur? Özel ihtiyaçlar olmadığı sürece (aşırı diş taşı, dişeti hassasiyeti, hassas dişler vb.) florid içerip içermediğine bakmak yeterlidir; çoğu kişinin ekstra bileşenlere ihtiyacı yoktur. Postmenopozda hassas diş eti ve kuru ağız söz konusuysa \*SLS (sodium lauryl sulphate)\* ve alkol içermeyen formüller daha iyi tolere edilebilir; \*aşındırıcılık değeri (RDA)\* düşük macunlar mineye nazık kalır. Bu konuda diş hekiminizden kişisel öneri almak — paketleri rastgele seçmekten daha dürüst bir yoldur. ### Bruksizm için gece koruyucu kullanmalı mıyım? Sabah çene ağrısı, kulaklara vuran baş ağrısı, dişlerde aşınma ya da "uyandığımda dişlerim kenetlenmiş gibi" hissi varsa — diş hekiminin değerlendirmesiyle özel hazırlanmış bir gece koruyucu (bite guard) önerilir. Postmenopozda stres ve uyku bölünmesi gıcırdatmayı sıklaştırır; gece koruyucu olmadan ilerlemiş gıcırdatma dişeti çekilmesine ve diş aşınmasına yol açar. ### Diş ipi kullandığımda kanama olursa ne yapayım? Yeni diş ipi kullanmaya başladığında ilk birkaç gün hafif kanama olabilir; bu çoğu zaman \*iki hafta içinde\* azalır. İki haftadan uzun süren veya yoğun kanama dişeti enflamasyonunun (gingivitis) işaretidir; diş hekimi değerlendirmesi gerekir. Diş ipinden vazgeçmek yerine — \*doğru teknik\* ve \*düzenli kullanım\* ile devam etmek doğru cevaptır. ### Periodontoloji ne kadar acil bir konu? Akut bir tablo (abse, ateş, şişlik) varsa \*bekleme yok\*. Ama çoğu periodontal hastalık \*sessiz ve yavaş ilerler\*; bu yüzden erken evrede hekimle konuşmak — geç evrede greft veya implant gündemine gelmekten çok daha kolay bir patikadır. Postmenopozda düzenli (6 ayda bir, gerekirse daha sık) kontrol bu sessiz ilerlemeyi erken yakalamanın en pratik yoludur. ## Kapanış Postmenopozda dişeti çekilmesi büyük bir tehdit değil; ama \*özen gösterilmesi gereken bir alan\*. Hormonal geçişin doku üzerindeki etkisi, sayısal pratik bakım disiplini ve düzenli diş hekimi takibi üçlüsü

çoğu kadında tabloyu kontrol altında tutmaya yeter. Diş hekiminize üç soruyla gidin: **"Benim çekilmem hangi tipte — hassas yapıya mı, bakteriyel kaynağa mı, ikisinin birleşimine mi bağlı?"**, **"Postmenopoz hassasiyetimi göz önünde bulundurarak bakım planımda neyi değiştirmem gerek?"**, **"Bruksizm değerlendirmesi ve gerekirse gece koruyucu için nasıl bir yol izleyelim?"**. Bu üç soru görüşmenin niteliğini değiştirir; size **"yüze yakışanı arayan"** — modaya kapılan değil, bedeninize ve gülüşünüze sürdürülebilir biçimde yatırım yapan — bir karar zemini açar. Doğal bir gülüş, ısrarla yapılmış olandan değil; doğru zamanda doğru ölçüde özen gösterilmiş olandan doğar. Postmenopoz dönemi, bu özene yeniden bakmak için doğal bir kavşaktır. Bilimsel Editör Notu Kanıt Düzeyi: (orta-iyi kanıt) Bu yazı bir **\*diş hekimi gözüyle pratik bakım rehberi\***dir; bireysel tıbbi değerlendirme veya tedavi önerisi olarak okunmamalıdır. Aşağıda kadın hastalıkları ve doğum perspektifinden tamamlayıcı bir klinik çerçeve eklendi. **\*\*Klinik bağlam:\*\*** Postmenopozal kadınlarda jinekoloji muayenelerinde "ağız sağlığım da değişiyor mu" sorusu giderek daha sık geliyor. Östrojen kaybının vajinal-üriner mukozadaki etkisi ile periodontal dokulardaki etkisi **\*aynı sistemik mekanizmanın iki farklı yüzü\***; biri daha açık konuşulan (vajinal atrofi), diğeri daha az konuşulan (dişeti hassasiyeti). Bu yazı az konuşulan tarafa pratik bir mercek tutuyor. **\*\*Mekanik çerçeve:\*\*** Östrojen reseptörleri (özellikle ER-β) periodontal ligament fibroblastları, gingival epitelyum ve alveolar osteoblastlarda eksprese olur. Postmenopozda azalan östrojen → azalmış kollajen sentezi + artmış inflammatory sitokin yanıtı (IL-1β, IL-6, TNF-α) + osteoklastik aktivite artışı. Bu mekanik zincir alveolar kemik kaybı ve periodontitis ilerleme hızını biraz arttırır. Ayrıca menopozda kuru ağız (xerostomia) prevalansı %25-40 arasında bildirilmiştir; tükürük azalması bakteriyel yükü ve plak birikimini kolaylaştırır. Sistemik osteoporoz ile alveolar kemik kaybı arasındaki korelasyon uzun süreli kohortlarda gösterilmiştir. **\*\*Klinik kırmızı bayraklar:\*\*** Hızlı ilerleyen dişeti çekilmesi — özellikle 50+ yaş ve sigara kullanıyorsa periodontoloji konsültasyonu öncelikli. Diabetik kadınlarda glisemik kontrol periodontitis seyrini doğrudan etkiler; HbA1c değerleri planın parçası olmalıdır. Sjögren sendromu, otoimmün tablolar ve kemoterapi öyküsünde mukozal bakım bireyselleştirilmelidir. Aktif osteoporoz tedavisinde olan hastalarda (özellikle bisfosfonat kullananlarda) invaziv diş prosedürleri öncesi mutlaka tedavi ekibinin bilgilendirilmesi gereklidir — osteonekroz riski nadir ama ciddi bir konudur. Hormon replasman tedavisi alan kadınlarda periodontal parametrelerin daha iyi seyrettiği bildirilmiştir; ancak HRT periodontal sağlık endikasyonu ile başlatılmaz. **\*\*Pratik bütünleşim:\*\*** Tedavi planı bir hiyerarşi izler — (1) sebep tespiti (hassas yapı / bakteriyel köken / kombinasyon); (2) günlük disiplinli ev bakımı (sabah-akşam fırçalama, diş ipi, asitli gıdadan yarım saat öncesi/sonrası kaçınma); (3) düzenli diştaşı temizliği (postmenopozda 6 → 3-4 ayda bire çekilebilir); (4) bruksizm değerlendirmesi ve gece koruyucu (bite guard); (5) periodontolojik konsültasyon (orta-ileri evre); (6) cerrahi seçenekler (greft) — yalnızca estetik veya sağlık açısından gereklilik durumunda. Sigara bırakma planı her aşamada risk profilini değiştirir. Tedavi planı diş hekimi-jinekolog- (gerekirse) endokrinolog üçgeninde bireyselleştirilir. **\*\*Bireyselleştirme uyarısı:\*\*** Sn. Karaosmanoğlu'nun yazısında paylaştığı "yüze yakışanı arayan" klinik-pratik yaklaşım genel popülasyon çerçevesidir; sizin tablonuzdaki çekilme tipi, alveolar kemik durumu, sistemik sağlık (diabet / osteoporoz / Sjögren), kullandığınız ilaçlar ve sigara durumu tedavi seçimine yön verir. Burada okuduklarınız bir başlangıç çerçevesidir, karar değil; sizin için uygun adımları diş hekiminiz — ve gerektiğinde jinekoloğunuzla birlikte — değerlendirmeniz önemlidir. — Doç. Dr. Senai Aksoy, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Estranova Tıbbi Editör Bu içerik genel bilgi amaçlıdır ve bireysel tıbbi değerlendirme yerine geçmez. Tanı ve tedavi kararları için sağlık profesyoneline başvurunuz.